

01

Sesgo de Confirmación

Búsqueda selectiva de evidencia

¿QUÉ ES?

Tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma las creencias previas, ignorando o descartando lo que las contradice.

SEÑALES EN SESIÓN

- Solo recuerda situaciones que confirman su visión negativa.
- Descarta o minimiza evidencia que contradice sus creencias.
- Busca activamente opiniones que refuercen lo que ya piensa.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Registro de evidencia a favor y en contra de la creencia.
- Técnica del abogado defensor: buscar activamente lo contrario.
- Preguntas socráticas: ¿qué datos estás descartando?
- Experimentos conductuales para testear creencias.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Busqué artículos sobre el tema y todos dicen que tengo razón. Es obvio que nunca voy a mejorar."

Alternativa:

Me enfoco en una parte de la información. Hay datos que no estoy considerando.

02

Sesgo de Anclaje

Dependencia excesiva del primer dato recibido

¿QUÉ ES?

El primer dato o impresión recibido actúa como ancla y condiciona todas las evaluaciones posteriores, incluso cuando es irrelevante.

SEÑALES EN SESIÓN

- Decisiones rígidas basadas en la primera opinión médica o diagnóstico.
- Dificultad para revisar una creencia formada tempranamente.
- El pasado condiciona de forma rígida la visión del presente.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Identificar el ancla: ¿cuándo y cómo se formó esa creencia?
- Buscar múltiples perspectivas antes de concluir.
- Técnica del rango: ¿cuál es el mejor y peor escenario posible?
- Psicoeducación sobre cómo se forman las primeras impresiones.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"El primer psicólogo me dijo que tenía un problema grave. Siempre lo tuve presente aunque otros digan lo contrario."

Alternativa:

Esa fue una opinión en un momento. Puedo buscar más información.

03

Efecto Halo

Generalización desde una característica

¿QUÉ ES?

Una característica positiva o negativa de una persona o situación influye en la percepción global, generando una impresión sesgada del conjunto.

SEÑALES EN SESIÓN

- Idealización o devaluación total de personas a partir de un solo rasgo.
- Dificultad para ver aspectos contradictorios en una misma persona.
- Expectativas rígidas basadas en la primera impresión.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Análisis de evidencia: ¿qué otras características tiene esa persona?
- Técnica del pastel: ¿qué porcentaje representa ese rasgo?
- Trabajo con pensamiento dicotómico como sesgo relacionado.
- Registro de conductas observables concretas.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Es tan exitoso en el trabajo que debe ser perfecto en todo. No puede haberme fallado."

Alternativa:

Una característica no define a una persona entera.

04

Sesgo de Disponibilidad

Sobreestimación de lo que viene fácil a la mente

¿QUÉ ES?

Se evalúa la probabilidad o frecuencia de algo según la facilidad con que ejemplos vienen a la mente, no según datos reales.

SEÑALES EN SESIÓN

- Sobreestimación del riesgo de eventos infrecuentes pero impactantes.
- Generalizaciones basadas en casos que se recuerdan fácilmente.
- Alta ansiedad ante situaciones con ejemplos negativos cercanos.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Búsqueda de datos objetivos sobre la frecuencia real del evento.
- Análisis de por qué ese ejemplo es tan accesible en la memoria.
- Registro de predicciones vs. resultados reales.
- Psicoeducación sobre memoria selectiva y emoción.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Mi tío tuvo cáncer. Estoy segura de que yo también lo voy a tener. Todos a mi alrededor se enferman."

Alternativa:

Ese caso me impactó mucho y por eso lo recuerdo fácil. Eso no lo hace más probable.

05

Sesgo de Retrospección

Hindsight bias / Ya lo sabía

¿QUÉ ES?

Tras conocer el resultado de un evento, se cree que ese resultado era predecible o inevitable, distorsionando el recuerdo de lo que se pensaba antes.

SEÑALES EN SESIÓN

- Autocrítica intensa por no haber previsto el problema.
- Dificultad para reconocer la incertidumbre que existía en ese momento.
- Culpa basada en debería haberlo sabido antes.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Línea de tiempo: reconstruir qué información había disponible entonces.
- Psicoeducación sobre incertidumbre y toma de decisiones.
- Diferenciación entre lo que sabías entonces y lo que sabés ahora.
- Trabajo con autocompasión y error humano.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Es obvio que esa relación iba a terminar mal. Debería haberlo visto. Fui una tonta."

Alternativa:

En ese momento no tenía la información que tengo ahora. Hice lo que pude con lo que sabía.

06

Error Fundamental de Atribución

Atribución asimétrica de conductas

¿QUÉ ES?

Tendencia a explicar la conducta propia por el contexto y la de otros por su personalidad, de forma sistemáticamente asimétrica.

SEÑALES EN SESIÓN

- Juicios duros hacia otros junto con justificaciones constantes hacia uno mismo.
- Yo llegué tarde por el tráfico; él llegó tarde porque es irresponsable.
- Dificultad para empatizar con el contexto ajeno.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Generar hipótesis situacionales sobre la conducta del otro.
- Técnica de la perspectiva: ¿qué podría estar viviendo esa persona?
- Análisis de doble estándar: ¿cómo lo juzgarías si fuera vos?
- Trabajo con empatía y teoría de la mente.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"No saludó porque es antipático. Cuando yo no saludé fue porque estaba apurada."

Alternativa:

Su conducta también puede tener una explicación situacional que no conozco.

07

Sesgo de Autoridad

Aceptación acrítica por la fuente

¿QUÉ ES?

Se acepta una afirmación como verdadera basándose principalmente en quién la dice, sin evaluar la evidencia que la sostiene.

SEÑALES EN SESIÓN

- Creencias rígidas basadas en lo que dijo una figura de autoridad.
- Dificultad para cuestionar diagnósticos u opiniones de especialistas.
- Sumisión en relaciones con figuras percibidas como superiores.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Diferenciación entre autoridad legítima y argumento de autoridad.
- Técnica de la evidencia: ¿qué datos sostienen esa afirmación?
- Explorar historia de vínculos con figuras de autoridad.
- Trabajo con asertividad y autonomía del pensamiento.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Mi médico dijo que iba a ser difícil, así que sé que no voy a mejorar. Si lo dijo él, es así."

Alternativa:

Esa es una opinión profesional. Puedo buscar más información y hacer mis propias preguntas.

08

Sesgo del Status Quo

Preferencia por lo conocido

¿QUÉ ES?

Tendencia a preferir el estado actual de las cosas y a percibir cualquier cambio como una pérdida, aunque el cambio sea objetivamente beneficioso.

SEÑALES EN SESIÓN

- Resistencia al cambio aunque la situación actual sea dañina.
- Más vale malo conocido que bueno por conocer.
- Ansiedad intensa ante situaciones nuevas o decisiones de cambio.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Análisis costo-beneficio: ¿qué se pierde y qué se gana con el cambio?
- Explorar el miedo específico detrás de la resistencia.
- Experimentos conductuales graduales hacia el cambio.
- Trabajo con tolerancia a la incertidumbre.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Sé que esta relación no me hace bien, pero dejarlo sería peor. Al menos sé lo que tengo."

Alternativa:

El miedo al cambio no es evidencia de que el cambio sea malo.

09

Sesgo de Optimismo

Subestimación del riesgo personal

¿QUÉ ES?

Tendencia a creer que es menos probable que eventos negativos nos ocurran a nosotros en comparación con otras personas.

SEÑALES EN SESIÓN

- Evitación de conductas preventivas por sentirse a salvo.
- Sorpresa o resistencia intensa ante adversidades reales.
- Minimización de síntomas o señales de alerta.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Psicoeducación sobre la vulnerabilidad universal.
- Análisis de factores de riesgo reales y personales.
- Trabajar el equilibrio entre esperanza y realismo.
- Prevención de recaída: ¿qué podría dificultar el proceso?

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Esas cosas les pasan a los demás. A mí no me va a afectar. Siempre me las arreglé solo."

Alternativa:

Ser optimista está bien, pero también puedo prepararme para las dificultades.

10

Efecto Dunning-Kruger

Sobreestimación de la propia competencia

¿QUÉ ES?

Las personas con menor conocimiento en un área tienden a sobreestimar su competencia, mientras que las más competentes tienden a subestimarla.

SEÑALES EN SESIÓN

- Resistencia a recibir orientación o psicoeducación.
- Ya sé lo que me pasa. No necesito que me expliquen.
- Abandono prematuro del proceso por sentirse curado.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Psicoeducación empática sobre el proceso terapéutico.
- Técnica socrática: preguntas que evidencien zonas ciegas.
- Validar el conocimiento que tiene y ampliar la perspectiva.
- Trabajar con humildad epistémica sin confrontación directa.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Leí sobre ansiedad y ya sé todo lo que me pasa. Creo que no necesito seguir viniendo."

Alternativa:

Saber el nombre de lo que me pasa es un primer paso, no el final del camino.

11

Sesgo de Supervivencia

Visión parcial basada en los éxitos visibles

¿QUÉ ES?

Se consideran solo los casos exitosos o visibles, ignorando los fracasos que no se muestran, lo que lleva a conclusiones distorsionadas.

SEÑALES EN SESIÓN

- Comparaciones basadas solo en lo que los demás muestran públicamente.
- Frustración ante el propio proceso al compararlo con historias de éxito.
- Subestimación de la dificultad real detrás de los logros ajenos.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Psicoeducación sobre lo que no se ve detrás de cada historia.
- Explorar los fracasos y dificultades detrás de los referentes.
- Registro propio de avances, sin comparación con otros.
- Trabajo con redes sociales y comparación social.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Todos los que empezaron terapia al mismo tiempo que yo ya están bien. Yo soy la única que no avanza."

Alternativa:

Solo veo los casos que funcionaron. No tengo información sobre los procesos que no se muestran.

12

Sesgo de Agrupamiento

Ver patrones donde no los hay

¿QUÉ ES?

Tendencia a percibir patrones, conexiones o causalidades en eventos aleatorios o sin relación entre sí.

SEÑALES EN SESIÓN

- Siempre me pasan cosas malas los lunes.
- Creencias supersticiosas que organizan la interpretación de eventos.
- Búsqueda de señales o significados en coincidencias.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- Análisis de frecuencia real: ¿cuántas veces ocurrió vs. no ocurrió?
- Psicoeducación sobre aleatoriedad y memoria selectiva.
- Registro neutro de eventos para contrastar con la creencia.
- Diferenciación entre correlación y causalidad.

EJEMPLO CLÍNICO

Pensamiento:

"Cada vez que uso esa campera, algo malo pasa. Ya no la quiero usar más."

Alternativa:

Estoy conectando dos eventos que probablemente no tienen ninguna relación.